Gestire problematiche di erogazione nonostante la presenza di ossigeno

Flusso assente o molto ridotto

Cosa riferisce il paziente

• “Il contenitore non eroga bene.”

• “Flusso assente o debole”.

• “Bollicine nel gorgogliatore assenti / ridotte / presenti ma poco evidenti”

NB: quindi si ha già la certezza che ci sia ancora ossigeno nel contenitore e sono già stati effettuati i controlli sull’indicatore di livello.

Porre sempre la domanda “Fa le bollicine nel bicchiere trasparente? Il gorgogliatore?”

Perché è importante questa verifica?

La presenza o l'assenza di bollicine ci fornisce una prima indicazione utile per individuare dove potrebbe trovarsi il problema.

- **Bollicine presenti:** indicano che l'ossigeno sta attraversando il gruppo riduttore e raggiunge il gorgogliatore. Questo non garantisce, però, che il flusso sia adeguato alla terapia prescritta o che l'ossigeno arrivi correttamente al paziente.
- **Bollicine assenti o molto ridotte:** possono indicare un problema di erogazione, una pressione insufficiente oppure un'anomalia nei collegamenti o nel gorgogliatore stesso.

Importante: questa domanda serve a orientare le verifiche successive, non a stabilire da sola se il contenitore funzioni correttamente.

Verifica immediata del flusso

Manopola di regolazione del flusso



- Controllare che sia esattamente sul numero della terapia prescritta.
- Se la manopola è posizionata sullo 0 il contenitore non eroga.
- Se è tra due numeri, il flusso può non uscire correttamente → riposizionare.

Se risolto → rassicurare il paziente. Se non risolto → passare al punto successivo.

Indicatore di pressione (se presente)

Tipo 1

L'indicatore misura la pressione interna del contenitore.

La lancetta deve trovarsi all'interno della fascia blu scura, che identifica un intervallo di pressione di esercizio accettabile, pari a circa **1,0–1,7 bar**. (Il valore 2,1 è il limite della scala e si trova oltre la zona rossa.

- **Lancetta nella fascia blu:** pressione interna considerata accettabile. Se il paziente segnala un flusso assente o ridotto, proseguire con le successive verifiche.
- **Lancetta fuori dalla fascia blu:** pressione esterna all'intervallo di esercizio indicato dal costruttore. Segnalare l'anomalia e seguire la procedura prevista per la verifica o sostituzione del contenitore.

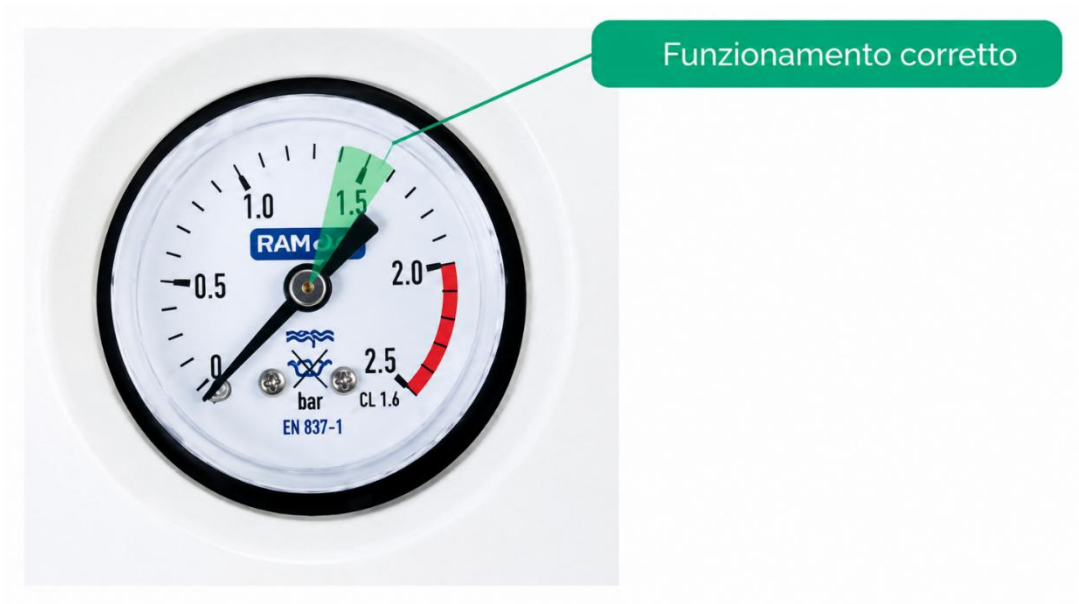
NB: l'indicatore misura la pressione interna del contenitore, non quella dell'ossigeno in uscita. Pertanto, una lancetta nella fascia blu non garantisce necessariamente una corretta erogazione al paziente.



Tipo 2

Durante il normale funzionamento la pressione indicata deve essere compresa tra circa 1,4 e 1,6 bar

Se supera 1,6 bar o è inferiore a 1,4 bar il contenitore è da sostituire



Se la pressione è corretta → avanti con le prove.

In caso di contenitore appena consegnato e caricato di recente, verificare il tempo trascorso dalla consegna.

Il contenitore potrebbe non aver ancora raggiunto la pressione di esercizio necessaria. *Attendere circa due ore dal caricamento* per consentire il ripristino della corretta pressione.

Verifica dei collegamenti



1) Connettore / farfallina dell'umidificatore

Controllare che il connettore tra tappo del gorgogliatore e rubinetto di erogazione (Gruppo riduttore) sia ben serrato. Se non risolto → proseguire.

2) Gorgogliatore / Umidificatore

Far verificare al paziente:

• Gorgogliatore ben avvitato (invitare il paziente a svitare e riavvitare). Se non fosse avvitato perfettamente il flusso potrebbe diminuire o essere assente per fuoriuscita di Ossigeno. La bollicine possono diminuire o essere assenti

• Verificare che non ci sia nessuna rottura/spaccatura. Nel caso ci fosse il flusso potrebbe diminuire o essere assente per fuoriuscita di Ossigeno. La bollicine possono diminuire o essere assenti

• Assicurarsi che non ci sia nessun accumulo di calcare in alcuna parte del gorgogliatore. Il calcare può ostacolare il flusso di O2 che non arriva al paziente adeguatamente.

• Acqua tra minimo e massimo (troppa acqua = flusso ostacolato). Ps: poca acqua poca umidificazione.

Se rotto

• Usare quello di riserva.

• Organizzare consegna per garantire sempre 2 gorgogliatori disponibili.

Se non ne ha → consegna urgente.

3) Cannula
Verificare che sia ben collegata.

• Non sia piegata, schiacciata o incastrata sotto mobili.
• Non presenti fori o usura.
• Sia integra e non ostruita.

Se risolto → rassicurare.

Cannula integra ma problema ancora presente → procedere con le altre prove.
Cannula rotta → usare quella di riserva + consegna per garantire sempre 2 cannule (o consegna urgente se manca la scorta).

Test del bicchiere

Far immergere la punta (nasellini) della cannula in un bicchiere d'acqua.
• Bollicine presenti → il contenitore eroga.
• Nessuna bollicina → possibile problema di pressione o erogazione.

Test pressione

Ricarica del portatile.

Provare a caricare il contenitore portatile dalla sorgente madre.
• Se non si carica o si carica molto lentamente, la pressione del contenitore principale può essere insufficiente.

Se il problema persiste

Se nessuna prova risolve → contattare il vettore per consegna/sostituzione del contenitore.

Se il problema persiste, il paziente continua a sostenere di " Non sentire l'Ossigeno" valutare una possibile farmacovigilanza.